

Mme A 35 ans, 0 par de 35 ans vous consulte à 10 5/7 SA semaines d'aménorrhée.

Dans ses antécédents on note une IVG chirurgicale à l'âge de 18 ans et une fausse couche spontanée de premier trimestre 2 ans auparavant.

Elle désire connaître les mesures à prendre pour être rassurée par rapport au risque de trisomie 21

Q1

- A** Un test de dépistage non invasif DPNI du premier trimestre par prise de sang maternelle et dosage de la fraction libre d'ADN fœtal circulant
- B** Un dépistage prénatal du premier trimestre par mesure de la clarté nucale et dosage des marqueurs sériques bêta-HCG et PAPP-A
- C** Un dépistage par échographie du premier trimestre puis échographie morphologique
- D** Un diagnostic prénatal par amniocentèse en raison de son âge > 35 ans et du risque plus élevé d'aneuploïdie
- E** Un diagnostic prénatal par choriocentèse en raison de son âge > 35 ans et du risque plus élevé d'aneuploïdie

P 777031

Session Quickstart Catalogue

Choose a session you want to

Session:

induction (777031)

Logout

Mme A 34 ans, Rhésus négative présente à 15 semaines d'aménorrhée un titre d'anti-D de 1:128 (positif à partir de 1:16).

Dans le cadre d'un premier mariage elle avait eu 3 grossesses : 2 fausses-couches spontanées et un accouchement à terme. Son premier enfant avait subi deux fois une exsanguino-transfusion pour hyperbilirubinémie peu après la naissance.

Quelle mesure est indiquée ?

- A** l'interruption de la grossesse
- B** un doppler de l'artère cérébrale moyenne fœtale
- C** la détermination du groupe Rhésus du père de l'enfant
- D** l'administration d'anti-D
- E** Une amniocentèse avec dosage de la bilirubine par spectrophotométrie de Liley

Une 3^{ème} geste, primipare de 22 ans est à 16^e semaine d'aménorrhée. Un an auparavant, elle a accouché par césarienne pour la naissance de son premier enfant. Elle se plaint de fatigue, de faiblesse généralisée et n'a jamais reçu de supplémentation de fer. L'hémoglobine est à 9.5 g/dl (norme: 12-16) et l'hématocrite est de 28 % (norme: 36-46).

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est la plus appropriée?

- A** Des examens complémentaires sont indispensables pour exclure une hémolyse
- B** Il s'agit d'une anémie en raison d'une dilution sanguine dans le cadre de la grossesse.
- C** L'anémie est le résultat d'un déficit en fer à mettre en relation avec les deux grossesses rapprochées.
- D** Si la patiente ne reçoit pas de supplément de fer durant la grossesse actuelle, la probabilité d'une nouvelle césarienne est significativement plus élevée
- E** Un supplément de fer prescrit après la fin de la grossesse actuelle suffit à rétablir les réserves en fer.

Mme B 2 geste, 1 pare avec un antécédent d'accouchement prématuré à 28 semaines d'aménorrhée doit être hospitalisée pour une menace d'accouchement prématuré pour cette nouvelle grossesse.

En cas de menace d'accouchement prématuré la maturation pulmonaire est envisagée jusqu'à combien de semaines d'aménorrhée ?

- A** 28 semaines d'aménorrhée
- B** 30 semaines d'aménorrhée
- C** 32 semaines d'aménorrhée
- D** 34 semaines d'aménorrhée
- E** 38 semaines d'aménorrhée

Mme U, 1 geste de 35 ans se présente à 34 5/7 semaines d'aménorrhée pour des céphalées et des œdèmes des membres inférieurs. L'examen clinique montre une TA 150/90 mm Hg. Au stix urinaire il a une protéinurie de 2 ++ et des leucocytes 1+. Le fond utérin est à 29 cm. Le monitoring fœtal est réactif non pathologique.

Que suspectez-vous immédiatement ?

- A** Une hypertension gestationnelle
- B** Une hypertension chronique
- C** Une pré-éclampsie
- D** Une éclampsie
- E** Un syndrome de HELLP

P 990123

Session Quickstart C
Question type: Op
Single Choice v 5

Mme A Ig/Op de 35 ans, à la 31^e semaine de grossesse, présente une tension artérielle de 160/100mmHg, une protéinurie de 700 mg/24h, des contractions régulières au cardiotocogramme et des douleurs épigastriques.

Quelle est la première mesure à prendre?

- A** mise en place d'une tocolyse intraveineuse
- B** mise en place d'une perfusion intraveineuse de sulfate de magnésium
- C** réalisation d'un examen échographique pour exclure un éventuel décollement prématuré du placenta
- D** administration d'une dose de corticoïdes
- E** administration d'un diurétique et/ou d'un bêta-bloqueur par voie intraveineuse

P 990123

Session Quickstart Catalogue

Question type: Options:

Single Choice 5

La Pré-éclampsie est une pathologie :

A

Se définissant par une TAH systolique ≥ 140 mmHg et TAH diastolique > 90 mmHg avec protéinurie de > 300 mg/24h.

B

Marquée par une hypertension artérielle ≥ 140 mmHg et/ou ≥ 90 mmHg et atteinte d'organes cibles.

C

Limitée à la grossesse et complètement résolutive après l'accouchement.

D

Dont le taux d'incidence s'élève à 10-15% des grossesses.

E

Qui peut conduire à des complications maternelles mais qui n'a pas de conséquence sur le développement fœtal.

Question K prime

Mme Z, 1 geste se présente à 30 semaines d'aménorrhée avec des contractions utérines régulières et un col raccourci à 1 cm. Devant cette menace d'accouchement prématuré vous souhaitez instaurer une tocolyse

Quelles sont les situations qui contre indiquent une tocolyse ?

- A** Décollement placentaire sévère
- B** Chorioamnionite
- C** Rupture prématurée des membranes
- D** Diabète gestationnel sous insuline

Mme E 1 geste se présente à 36 semaines d'aménorrhée pour des douleurs abdominales d'apparition soudaine avec un saignement de sang frais de faible quantité.

La patiente a des pulsations à 80/ minute et une TA 150/90 mmHg. Au cardiogramme le rythme cardiaque fœtal est de 160 battements/ minute, les contractions utérines aux 5 minutes avec un utérus se relâchant mal.

L'examen au spéculum montre une faible quantité de sang rouge s'extériorisant au niveau du col et la présence de vieux sang dans le cul de sac vaginal postérieur. Le col est long de 2 cm et fermé.

Que suspectez-vous en priorité?

- A** Un placenta praevia
- B** Une rupture utérine
- C** Un décollement placentaire d'un placenta normalement inséré
- D** Une hémorragie de Benkiser
- E** Un début de travail

Mme A primigeste est suivie à votre consultation.

Elle vient pour son contrôle à 25 semaines d'aménorrhée. Le résultat du dépistage du diabète gestationnel est pathologique.

Glycémie à jeun = 5.8mmol/L (≥ 5.1) ; à 60min. = 10.7mmol/L (≥ 10) ; à 120min. = 8 mmol/L (≥ 8.5) .

Quelle prise en charge proposez-vous?

- A** Contrôle des glycémies et traitement par régime fractionné normocalorique, avec hydrates de carbone (40-50% des calories)
- B** Instauration d'un traitement d'insuline
- C** Hospitalisation pour surveillance des glycémies
- D** Privilégier le repos pour éviter les surcharges
- E** Maturation pulmonaire fœtale en raison du risque de prématurité

Une femme de 25 ans, 2 geste nullipare consulte à 12 semaines d'aménorrhée.

Elle a eu un contrôle des sérologies à 10 semaines d'aménorrhée qui montre la présence d'IgG et d'IgM pour le CMV (cytomégalovirus).

Que lui proposez-vous ?

- A** Une interruption de grossesse car une infection à CMV peut provoquer des atteintes fœtales graves
- B** Une échographie fœtale: si elle est normale, la patiente peut être rassurée
- C** Refaire la sérologie CMV avec un test d'avidité pour dater le moment de l'infection maternelle
- D** Une amniocentèse à 15 semaines d'aménorrhée pour diagnostiquer une infection foetale
- E** En l'absence de symptomatologie maternelle, la patiente peut être rassurée et on ne recommande pas d'autre examen

Une patiente 28 ans, 2^e par se présente à l'hôpital à terme pour des contractions utérines régulières. Elle a un BMI à 35 kg/m². Son premier enfant né par voie basse pesait 4 kg à la naissance. Les examens cliniques et échographiques au cours de la grossesse actuelle parlent en faveur d'un bébé macrosome.

À l'admission, le col utérin est dilaté à 4 cm et la présentation céphalique se trouve à 1 cm au-dessus des épines sciatiques.

Quelle démarche est indiquée?

- A:** l'expectative et l'observation de la progression de l'accouchement
- B:** la césarienne afin de réduire le risque de dystocie des épaules
- C:** la pelvimétrie radiologique et césarienne en cas de suspicion de bassin rétréci
- D:** la stimulation des contractions par syntocinon
- E:** l'anesthésie péridurale dans le but d'obtenir un relâchement des muscles du plancher pelvien

Mme M s'est présentée à terme avec un travail spontané. Elle est à 5 cm de dilatation.

On constate l'apparition soudaine d'une bradycardie fœtale qui persiste malgré l'administration d'une tocolyse, un changement de position de la patiente et l'administration d'oxygène.

Quelle complication de l'accouchement n'explique pas la survenue de cette bradycardie fœtale?

- A** Une rupture utérine
- B** Un décollement placentaire
- C** Une procidence du cordon
- D** Une compression de la veine cave
- E** Une embolie de liquide amniotique

Une sage-femme vous appelle en urgence auprès d'une patiente de 27 ans qui présente un cardiotocogramme (CTG) avec un tracé pathologique. Le toucher vaginal vous permet de palper le cordon ombilical dans le vagin. La tête fœtale est située 1-2 travers de doigt au-dessus de la ligne interspinale et la dilatation à 8 cm.

Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas?

- A** repousser sur le champ la tête fœtale vers le haut et la maintenir ainsi
- B** procéder à toutes les préparations d'une césarienne en urgence
- C** essayer de pratiquer sur le champ un accouchement vaginal avec l'aide d'un appui sur le fond utérin (Manœuvre de Kristeller)
- D** instaurer une tocolyse d'urgence

Après la délivrance, la face maternelle du placenta présente une érosion localisée avec du sang. Le placenta paraît toutefois complet car il ne manque aucun cotylédon. L'utérus est mal contracté. On observe encore un léger écoulement de sang par le vagin 15 minutes après l'accouchement. Les pertes de sang jusqu'au moment présent s'élèvent à environ 800 ml.

Quelle mesure est à prendre?

- A:** faire une révision de la cavité sous narcose
- B:** administrer une transfusion sanguine
- C:** administrer une perfusion rapide d'ocytocine
- D:** cureter sous narcose
- E:** attendre et ne rien faire pour le moment

Mme X, est une 2^e geste, 1^{er} par de 24 ans.

La grossesse a été marquée par une hospitalisation pour menace d'accouchement prématuré. Elle a finalement accouché à 38 SA par voie basse d'une fille en bonne santé. Au 4^{ème} jour vous la trouvez en pleurs dans sa chambre : elle dort mal, n'a pas d'appétit et se sent triste et angoissée. Elle est soucieuse pour son enfant et exprime un sentiment d'incompétence.

Vous pensez à

- A** Un trouble de la personnalité
- B** Un baby-blues avec une indication pour un soutien réconfortant et bienveillant de la part de l'équipe soignante obstétricale et de la famille
- C** Une dépression du post partum avec une indication pour un traitement d'antidépresseur
- D** Une psychose du post partum avec une indication pour un suivi psychiatrique en ambulatoire
- E** Une psychose du post partum avec une indication pour une hospitalisation en milieu psychiatrique

Une anesthésie péridurale est pratiquée chez une III-pare de 32 ans à la 40e semaine de grossesse en travail d'accouchement. Le poids présumé fœtal est de 3500 g. Après l'installation de l'anesthésie, une bradycardie fœtale sévère apparaît.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- A** Un décollement placentaire
- B** une procidence du cordon ombilical
- C** une anémie fœtale
- D** une bradycardie fœtale d'origine toxique
- E** une chute de tension maternelle

Mme M 3geste, 0 pare de 35 ans vous consulte en début de grossesse. Elle a des cycles réguliers, utilise le préservatif comme moyen de contraception. Comme elle n'a plus eu ses règles et se sent nauséuse, elle a acheté un test de grossesse urinaire en pharmacie qui s'est révélé positif. Vous effectuez un examen clinique et une échographie endovaginale. Vous visualisez une grossesse intrautérine correspond à 10 semaines d'aménorrhée

Quelle mesure échographique permet de déterminer l'âge gestationnel à ce stade?

- A** Mesure du diamètre bipariétal
- B** Mesure de la longueur fémorale
- C** Mesure de la longueur céphalo-caudale
- D** Mesure de la longueur céphalo-fémorale
- E** Mesure du périmètre abdominal

Une patiente vous consulte en début de grossesse. Elle ne souhaite pas garder cette grossesse et vous demande les possibilités concernant l'interruption de grossesse.

L'interruption de grossesse n'est pas punissable si...?

A

Sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des 12 semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Un avis conforme est demandé à un deuxième médecin expert.

B

Sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des 12 semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme et la conseiller.

C

Un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité du fœtus au cours des 12 semaines suivant le début des dernières règles.

D

Un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité du fœtus au cours des 22 semaines suivant le début des dernières règles.

E

Un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité du fœtus quelque soit l'âge gestationnel.

Mme U est une patiente 2g, 1p de 29 ans à 11 semaines d'aménorrhée. Elle est inquiète car une de ses amies lui a parlé du risque de non fermeture du tube neural (spina bifida) si les femmes ne prennent pas d'acide folique en période périconceptionnelle. Mme U n'a pas pris d'acide folique.

Quelle est la mesure proposée pour le dépistage d'anomalies de type non fermeture du tube neural ?

P 990123

Session Quickstart

- A Un dépistage prénatal du premier trimestre par dosage des marqueurs sériques bêta-HCG et PAPP-A.
- B Un dépistage prénatal du premier trimestre par dosage du marqueur sérique alpha-foetoprotéine.
- C Un dépistage prénatal du deuxième trimestre par dosage des marqueurs sériques bêta-HCG et PAPP-A.
- D Un dépistage prénatal du deuxième trimestre par dosage du marqueur sérique alpha-foetoprotéine.
- E Un dépistage par échographie du premier trimestre puis échographie morphologique.

Mme U, 2g,1p de 30 ans se présente à 39 SA pour des douleurs abdominales crampiformes depuis 3 heures. Elle a accouché par césarienne 3 ans auparavant. A l'examen on note des contractions aux 10 minutes et le col est dilaté de 2 cm. Le fœtus est en présentation podalique.

Quelle est la mesure est la plus appropriée

- A Proposer de revenir lorsque les contractions sont plus fréquentes.
- B Evaluer possibilité d'accouchement voie basse podalique
- C Faire une maturation pulmonaire.
- D Administrer une tocolyse d'urgence et faire une version céphalique externe.
- E Faire une mesure du segment inférieur et si le segment est épais proposer un accouchement par voie basse.

Mme W est à J 1 post partum d'un accouchement par voie basse après déclenchement pour rupture des membranes de plus de 24 heures. Elle présente un état fébrile à 38,5.

Quel est le diagnostic à évoquer ?

- A** Une endométrite
- B** Une mastite
- C** Une infection urinaire
- D** Une thrombose de la veine ovarienne
- E** Un abcès pelvien